

SUICÍDIO — AVALIAR RISCO E PLANEJAR

EPIDEMIOLOGIA E IMPACTO

MAGNITUDE DO PROBLEMA

- Suicídio: 3ª causa de morte em jovens de 15-29 anos; 12.000 mortes/ano no Brasil
- Para cada morte, 20-30 tentativas; iceberg — subnotificação significativa
- Fatores de risco: depressão (50%), transtorno bipolar, esquizofrenia, álcool/drogas, dor crônica
- Tentativa prévia = maior preditor isolado de suicídio consumado (risco 30-40x maior)
- Janela de oportunidade: 50% dos que morrem por suicídio consultaram um médico no mês anterior

AVALIAÇÃO DO RISCO — ESTRATIFICAÇÃO

Risco	Características	Conduta
ALTO	Plano concreto + meio disponível + intenção imediata. Tentativa recente grave. Psicose ativa. Agitação extrema.	Internação involuntária, UTI se intox. grave, psiquiatria urgente, retirar meios
MODERADO	Ideação ativa sem plano concreto. Tentativa de baixa letalidade. Depressão grave. Alcoolismo ativo.	Avaliação psiquiátrica imediata, observação, considerar internação voluntária
BAIXO	Ideação passiva ('quero morrer' sem intenção/plano). Sem tentativa. Bom suporte social. Insight preservado.	Alta com plano de segurança, encaminhamento urgente ao CAPS/psiquiatra, retorno em 24-48h

COMO PERGUNTAR — QUEBRAR O TABU

PERGUNTAR NÃO AUMENTA O RISCO

- 'Você teve pensamentos de se machucar ou de não querer mais estar vivo?'
- 'Você está pensando em suicídio?' — pergunta direta é segura e necessária
- 'Você tem algum plano de como faria?' — avaliar especificidade do plano
- 'Você tem acesso a essa forma?' — arma, medicação, local
- 'O que impediu você até agora?' — avaliar fatores de proteção
- Escuta ativa, sem julgamento, ambiente privado, sem interrupções

FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO

Fatores de Risco	Fatores Protetores
Depressão + ansiedade severas	Suporte familiar e social forte
Tentativa prévia (principal fator isolado)	Motivação religiosa para viver
Acesso a meios letais (arma de fogo)	Filhos pequenos, responsabilidade com outrem
Isolamento social, divorciado, viúvo	Insight sobre o transtorno e busca de ajuda
Abuso de álcool/drogas	Vínculo terapêutico estabelecido
Doença física grave e crônica	Plano de segurança acordado e compreendido
Histórico familiar de suicídio	Esperança de melhora com tratamento

PLANO DE SEGURANÇA E INTERNAÇÃO

Plano de Segurança (alta segura)

- 1. Sinais de alerta que o paciente reconhece
- 2. Estratégias internas de enfrentamento
- 3. Pessoas para distrair (família, amigos)
- 4. Profissional ou serviço de saúde para contatar
- 5. RESTRIÇÃO DE MEIOS: retirar armas, medicamentos estocados
- CVV: 188 (24h, gratuito) — passado ao paciente na alta

Internação Involuntária (Lei 10.216)

- Indicada quando: risco iminente sem capacidade de contrato terapêutico
- Notificar familiar e comunicar ao MP em 72h
- Pode ser feita por médico não psiquiatra
- Sempre preferir voluntária se possível
- Documentar: avaliação, risco, conduta, responsável
- Ambiente seguro: retirar objetos cortantes, cabos, medicamentos do quarto

CHECKLIST — AVALIAÇÃO DE RISCO NO PS

SISTEMATIZAR A AVALIAÇÃO

- ☐ Perguntar diretamente sobre ideação suicida — não esperar o paciente trazer
- ☐ Avaliar plano: método, acesso ao meio, data/local — quanto mais específico, maior o risco
- ☐ Identificar tentativa prévia e sua letalidade real vs percebida pelo paciente
- ☐ Fatores de risco ativos: depressão, psicose, álcool, dor crônica, doença terminal
- ☐ Fatores de proteção: vínculo familiar, religião, filhos, insight
- ☐ Estratificação: alto (internar) / moderado (avaliar) / baixo (plano segurança + retorno)
- ☐ Documentar detalhadamente — medicolegalmente essencial

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

CFM / Adaptada

Qual é o fator de risco isolado mais importante para um novo episódio de suicídio consumado?

- A) Depressão grave em tratamento
- B) Abuso de álcool crônico
- C) Tentativa de suicídio prévia
- D) Divorciado sem filhos
- E) Histórico familiar de depressão

QUESTÃO 2

FMUSP / Adaptada

Paciente com ideação suicida, plano concreto (saltar de edifício), local identificado e intenção para 'hoje à noite'. Qual é a conduta CORRETA?

- A) Alta com plano de segurança e retorno em 48h
- B) Encaminhamento ao CAPS na semana seguinte
- C) Internação psiquiátrica urgente, involuntária se necessário, retirando o acesso ao meio
- D) Prescrever antidepressivo e observar 30 dias
- E) Solicitar avaliação ambulatorial e aguardar vaga

QUESTÃO 3

AMRIGS / Adaptada

Perguntar diretamente sobre suicídio para um paciente em crise:

- A) Aumenta o risco de suicídio — deve ser evitado
- B) É desnecessário se o paciente não menciona o assunto
- C) Não aumenta o risco e é essencial para a avaliação correta
- D) Deve ser feito apenas por psiquiatra
- E) É contraindicado em menores de 18 anos

QUESTÃO 4

SES-DF / Adaptada

Qual componente do plano de segurança é considerado o mais eficaz na redução de suicídio?

- A) Fornecer o número do CVV (188)
- B) Restrição de meios letais (guardar armas, retirar medicamentos estocados)
- C) Orientar sobre terapia cognitivo-comportamental
- D) Prescrever antidepressivo na alta do PS
- E) Agendar retorno em 30 dias

QUESTÃO 5

UFPR / Adaptada

Segundo a Lei 10.216, quando é possível internar involuntariamente um paciente por risco de suicídio?

- A) Apenas mediante autorização judicial prévia
- B) Somente se há psiquiatra disponível no momento
- C) Quando há risco iminente para si e o paciente não tem capacidade para contrato terapêutico
- D) Nunca — toda internação psiquiátrica deve ser voluntária
- E) Apenas se familiares solicitarem por escrito

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: C

Tentativa de suicídio prévia é o fator de risco isolado mais forte para suicídio consumado (risco 30-40x maior). Perguntar sobre histórico de tentativas é essencial em qualquer avaliação de risco.

QUESTÃO 2 → Resposta: C

Plano concreto + meio identificado + intenção imediata = risco ALTO → internação urgente. Retirar acesso ao meio. Internação involuntária é legal e ética quando há risco iminente. Documentar toda a avaliação.

QUESTÃO 3 → Resposta: C

Estudos mostram que perguntar diretamente sobre suicídio NÃO aumenta o risco — na verdade, permite avaliação adequada e mostra ao paciente que o médico se importa. É uma das intervenções mais importantes no PS.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Restrição de meios (lethal means counseling): retirar armas de fogo, guardar medicamentos com familiar, remover objetos cortantes — é a intervenção com maior evidência de redução de suicídio consumado. Reduz a impulsividade-letal.

QUESTÃO 5 → Resposta: C

Lei 10.216: internação involuntária é permitida quando há risco iminente à vida e o paciente não tem capacidade para contrato terapêutico. Pode ser feita por qualquer médico. Notificar família e comunicar ao MP em 72h.

SM24
Suporte ao Plantão Médico